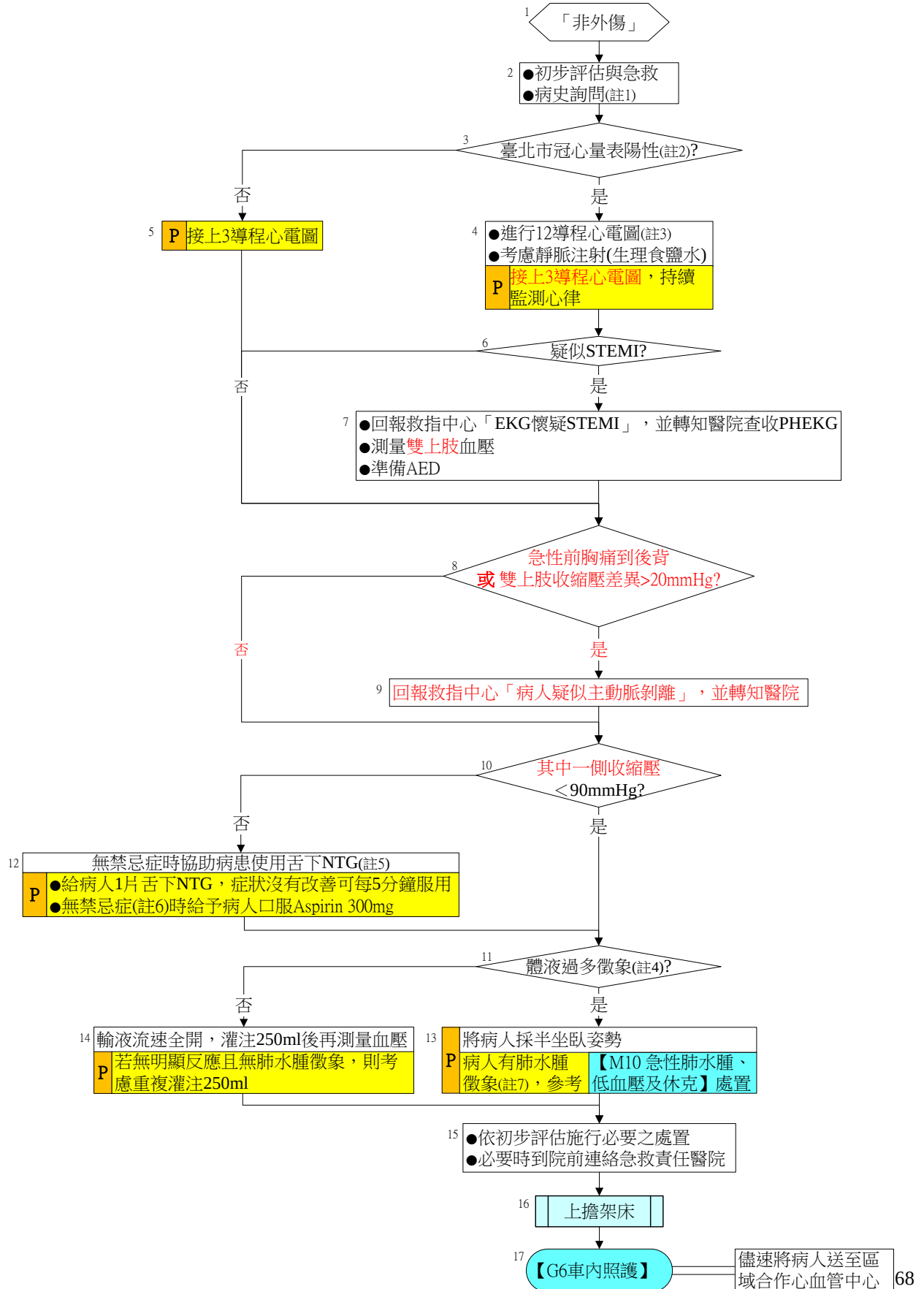


M7 疑似缺血性胸痛

程 序



要 旨

- 一、意識清醒且主訴「胸痛/胸悶」的病人，建議使用本程序。
- 二、經病史詢問與病人評估後懷疑為「缺血性胸痛」者，符合「危急個案」。除依本程序處置外，請同時參考【G5 危急個案】處置。
- 三、缺血性胸痛原則上不需常規給氧，如無呼吸窘迫徵候，維持血氧值 90%以上即可。

註 解

註 1>

「缺血性胸痛」包括：穩定心絞痛、不穩定心絞痛、心肌梗塞三種病。其中後兩者「不穩定心絞痛、心肌梗塞」又稱為「急性冠心症 (acute coronary syndrome; ACS)」。

急性冠心症病人有很高機會發生OHCA，故須特別留意。另外，少部份缺血性胸痛乃「主動脈剝離 (dissecting aortic aneurysm;DAA)」導致，其典型之胸痛特徵為急性發作由前胸痛到後背，且可能合併任何一項冠心症的臨床表現。

- 一、缺血性胸痛發作：現場以詢問現病史（OPQRST方式）、配合理學檢查為最佳判斷方式。

範例

1、Onset/Origin：症狀的發生當時狀況

什麼時候開始覺得胸痛的?剛發生胸痛時你在做什麼?有沒有發生過類似的胸痛?

2、Provoke/Palliation：有無加劇或緩解此一症狀的因素。

有沒有什麼姿勢會加重或是減輕你的肚子痛?走路或者爬樓梯會不會引發你這樣的胸痛?休息會不會讓胸痛改善?

3、Quality：症狀的性質

你可以形容一下是怎樣的不舒服嗎?是悶悶的痛還是像刀在割?這樣的疼痛是一陣一陣的還是一直持續?

4、Region/Radiation：位置以及有無轉移

你覺得疼痛的位置在哪裡?疼痛的位置有沒有沒改變?這樣的疼痛會不會傳到其他的部位?

5、Severity：嚴重度

你覺得有多痛?如果疼痛的嚴重度從 1 分到 10 分，1 分代表最不痛，10 分代表最

痛，你覺得你現在的疼痛大約幾分？

6、Time/Duration：持續時間與頻率

每 1 次的疼痛約持續多久或多久疼痛 1 次。

二、若現病史無法完整獲得時，可依相關病史及症狀來判斷是否為缺血性胸痛。下列情形傾向是缺血性胸痛的發作（依高度可能性至中度可能性）依序為：主訴胸痛、胸悶病人，併有已知有心肌梗塞病史、或呈現冒冷汗、或端坐呼吸（可能有二尖脈逆流雜音、肺水腫及肺濕囉音等）、或有糖尿病、或有其它血管病史（如腦中風過或週邊血管阻塞）。

三、過去病史：按「之前、吃、過、藥、敏、感」。

四、老人、糖尿病人、女性病人可能有不典型症狀（包括喘、上腹痛、心悸感、冒冷汗、昏厥感等），此等症狀應考慮為等同心絞痛（angina equivalence）。

註 2>

「臺北市冠心量表」：

一、施行對象(男性20歲以上或女性50歲以上)，發生以下任1項(甲或乙)時，為『臺北市冠心量表』陽性，考慮送醫前執行12導程心電圖(以下簡稱EKG)：

(一) 甲：胸痛或胸悶。

(二) 乙：同時具備1喘、2冒冷汗、3噁心或嘔吐、4心臟病史之任2項者。

二、排除條件：病人或家屬拒絕現場做EKG。

註 3>

救護人員於現場完成EKG後，均應進行傳輸，並以救護案號為心電圖案號，惟其中機器研判為疑似STEMI者，必須請救指中心通知接收醫院查看EKG。

註 4>

體液過多徵象可能包括：端坐呼吸、頸靜脈怒張、聽診有肺囉音、下肢水腫等。

註 5>

EMT2協助病人服用NTG，每5分鐘建議服用1次，到院前最多服用3次（包含病人自行服用），每次使用前監測其收縮壓 $\geq 90\text{mmHg}$ 。脈搏 < 50 或 ≥ 100 次/分時應小心使用、48小時內使用過壯陽藥物之病人不可服用。

註 6> **P**

確定對Aspirin過敏者、活動性潰瘍出血或經口進食困難之病人不建議使用。

若病人表現出急性前胸痛到後背，或者雙上肢收縮壓差異 $> 20\text{mmHg}$ ；則需高度疑似主

動脈剝離，不建議使用Aspirin以免增加出血風險。

註 7> **P**

肺水腫徵象是指呼吸淺快、端坐呼吸、頸靜脈怒張、聽診有肺囉音等。